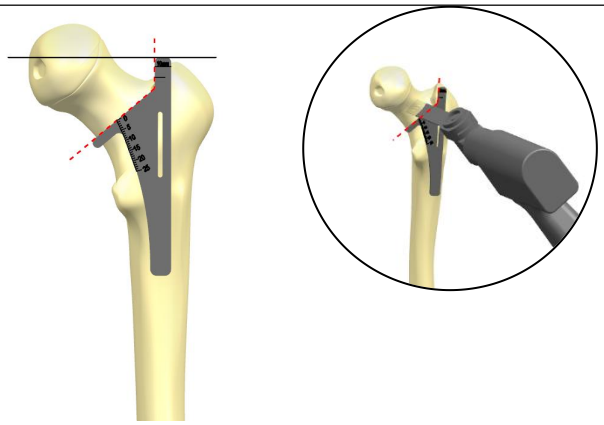
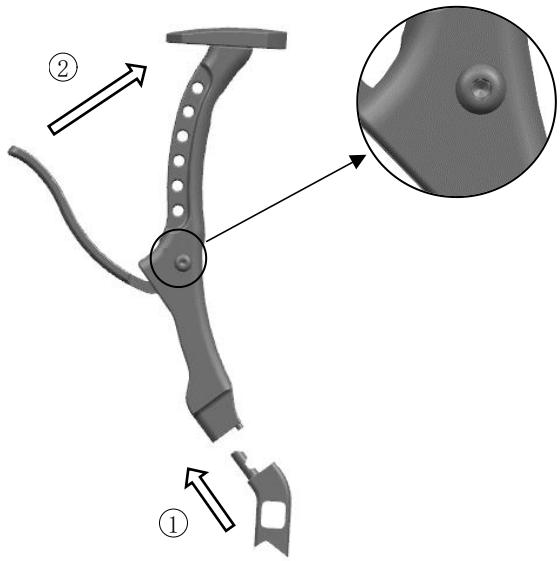
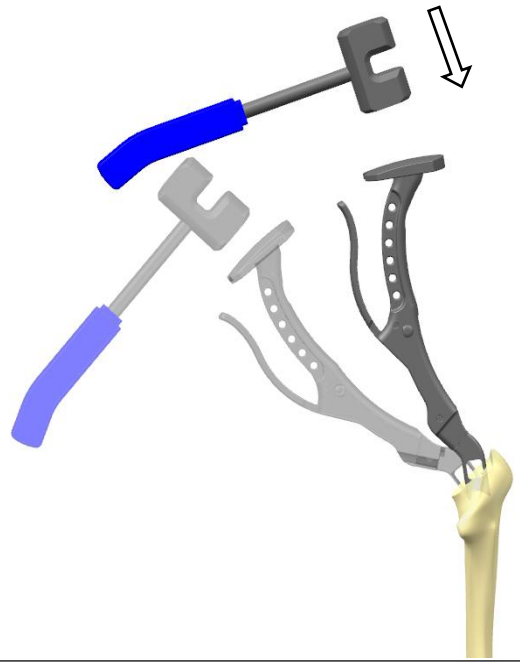
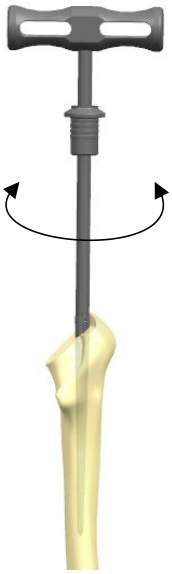
Delta® Стегновий компонент

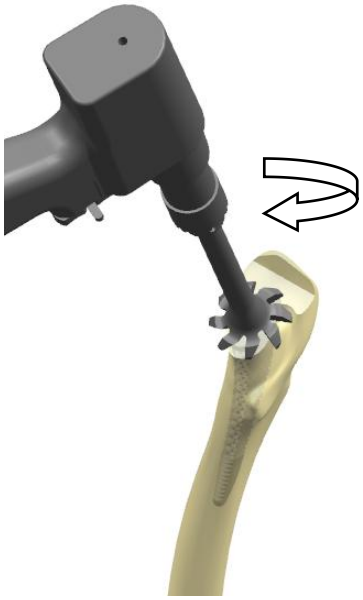
Протез кульшового суглоба — безцементний стегновий компонент

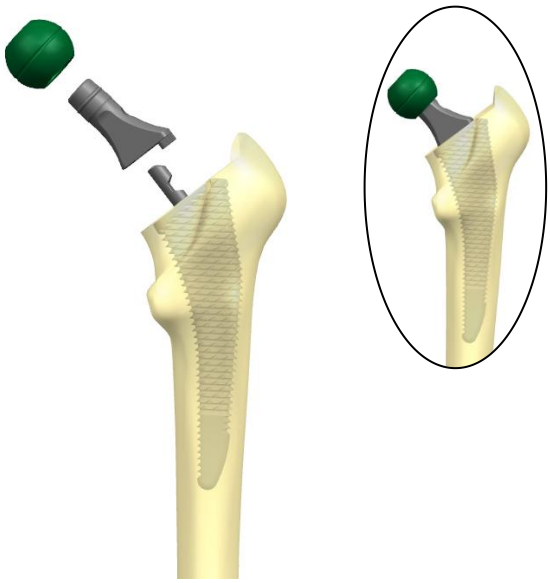


ХІРУРГІЧНА ТЕХНІКА

	Феморальна остеотомія Вирівняйте шаблон резекції шийки стегнової кістки з верхівкою великого вертлюга або лінією розмітки пластини. Позначте лінію остеотомії. Виконайте резекцію головки стегнової кістки.
	Відкриття стегнового каналу Спочатку встановіть розкривач на імпактор рашпіля стегнової кістки, після чого затягніть рукоятку імпактора рашпіля стегнової кістки. Імпактор рашпіля стегнової кістки має конструкцію швидкого роз'єднання, що є зручним для очищення та технічного обслуговування.

	Відкриття стегнового кістково-мозкового каналу за допомогою розкривача. Напрямок відкриття повинен відповідати осі стегнового кістково-мозкового каналу. Штифт-пуансон також можна використовувати під кутом, якщо це необхідно.
	Підготовка стегнової кістки З'єднайте конічний розширювач з Т-подібною рукояткою, щоб розпочати відкриття дистального стегнового кістково-мозкового каналу.

	Розширення стегнового кістково-мозкового каналу Оберіть рашпіль найменшого розміру та приєднайте його до імпактора рашпіля стегнової кістки, після чого зафіксуйте рукоятку імпактора.
	Розширте стегновий кістково-мозковий канал за допомогою рашпіля стегнової кістки. Розпочніть доступ до стегнового кістково-мозкового каналу, використовуючи рашпіль найменшого розміру. Орієнтація рашпіля повинна враховувати напрямок та антефлексію стегнового каналу.
	Препарування калькара Приєднайте розширювач калькара до електроінструмента та встановіть його на циліндр. Переконайтеся, що кісткова пилка обертається до контакту зі стегновою кісткою, щоб згладити поверхню остеотомії.

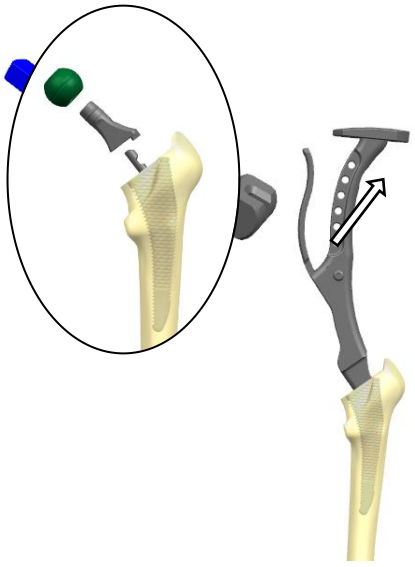


Пробна збірка

Приєднайте відповідний пробний шийковий компонент до рашпіля, після чого з'єднайте пробну головку стегнової кістки необхідного діаметра та довжини шийки з пробним шийковим компонентом.

Спочатку виконайте пробу з пробною головкою стегнової кістки (+5), щоб оцінити, чи необхідно коригувати довжину шийки.

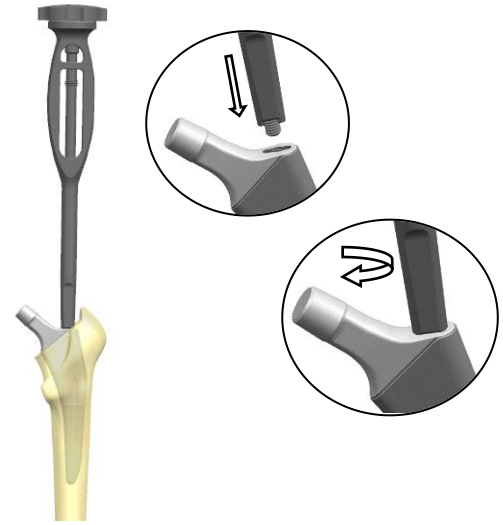
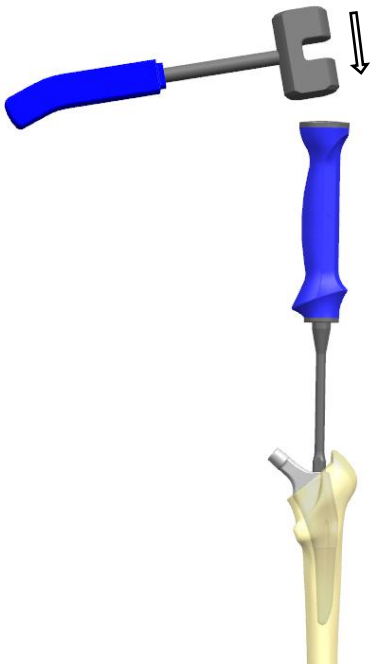
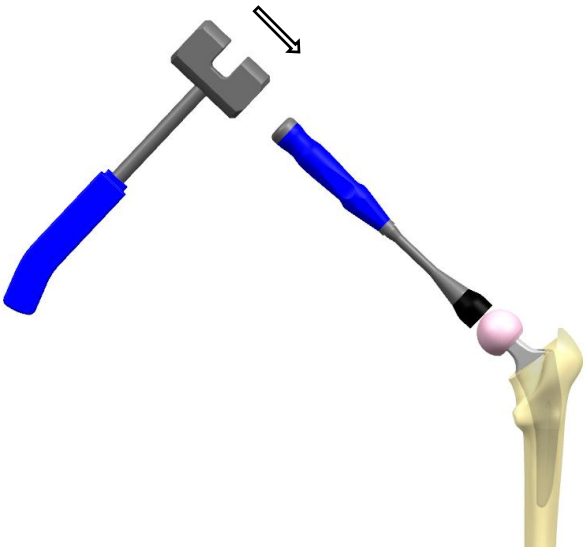
Пробний шийковий компонент має вбудований магніт для швидкого та надійного магнітного кріплення до рашпіля, що забезпечує зручність використання та тривалий термін служби.



Видаліть пробні компоненти та рашпіль стегнової кістки.

Видаліть пробну головку стегнової кістки та пробний шийковий компонент.

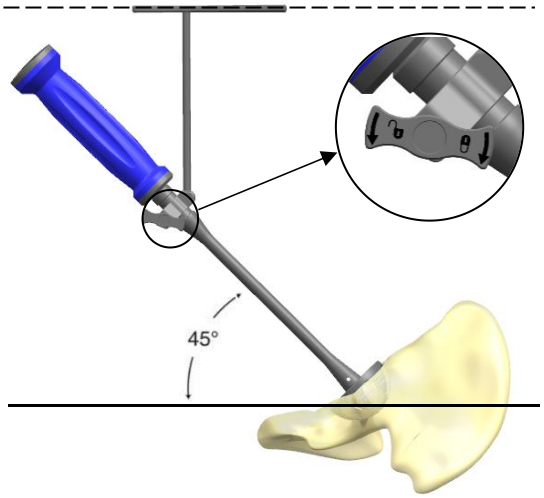
Потім з'єднайте імпактор рашпіля стегнової кістки з рашпілем і нанесіть удари молотком по імпактору, щоб витягти рашпіль.

	**Встановлення ніжки** Приєднайте ніжку до тримача стегнової ніжки. З'єднайте наконечник тримача зі стегновою ніжкою та обертайте колесо на кінці тримача, доки воно не забезпечить надійну фіксацію стегнової ніжки. Стандартна конструкція з'єднання сумісна з усіма безцементними стегновими ніжками виробництва iKey Medical.
	**Зафіксуйте стегнову ніжку за допомогою імпактора.** Під час імплантації опір має відчуватися на відстані 10–15 мм до досягнення остаточного положення. Обережно постукуйте молотком по імпактору ніжки, щоб посадити протез до його повної посадки.
	**Встановлення головки стегнового компонента** Тримайте конус стегнової ніжки чистим і сухим. Насадіть головку стегнового компонента на конус, одночасно натискаючи та обертаючи її до належного положення. Для встановлення головки на стегнову ніжку використовуйте імпактор головки стегнового компонента.



Розсвердлювання кульшової западини

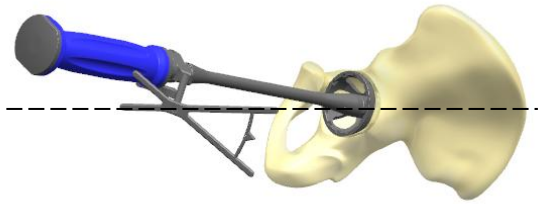
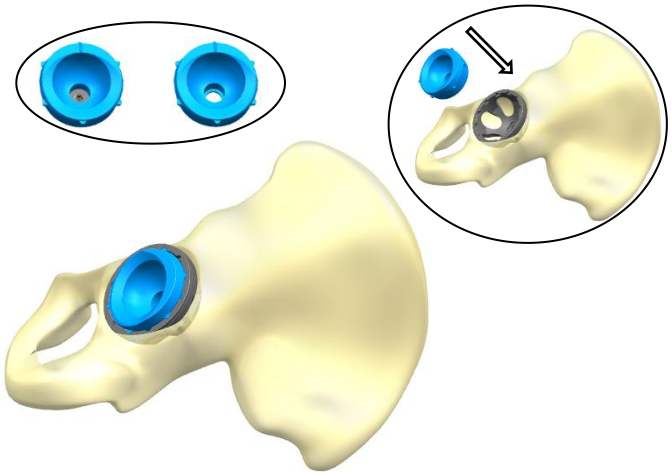
Метою розсвердлювання кульшової западини є відновлення центру первинної кульшової западини. Початковий розмір фрези зазвичай на 6–8 мм менший за прогнозований розмір ацетабулярного компонента. Подальше розсвердлювання виконують із кроком 1 мм. Фрезу використовують для поступового розширення кульшової западини до формування нової кульшової западини півсферичної форми.

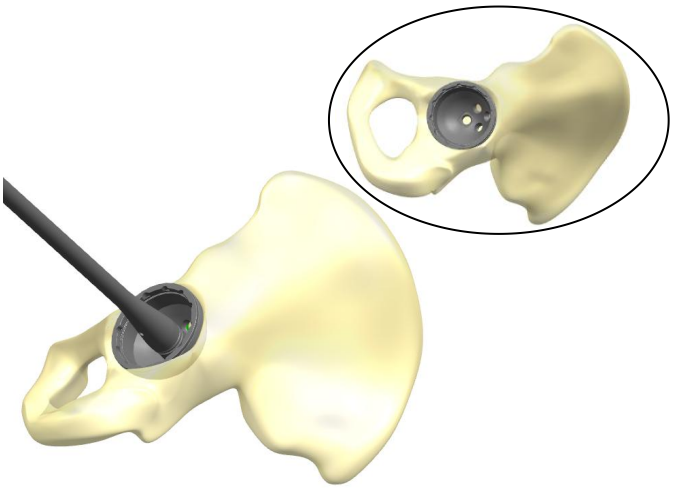
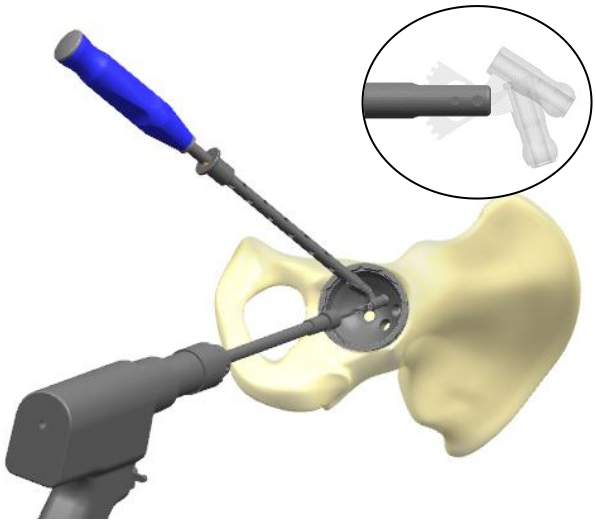


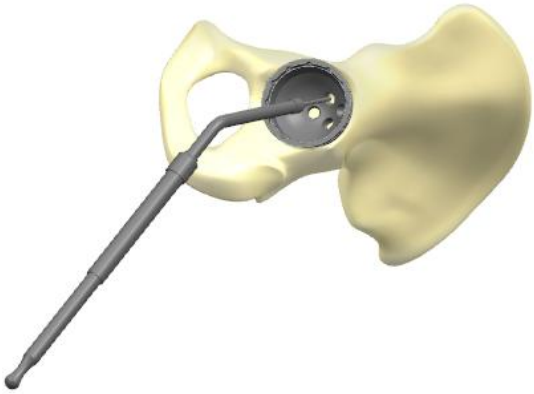
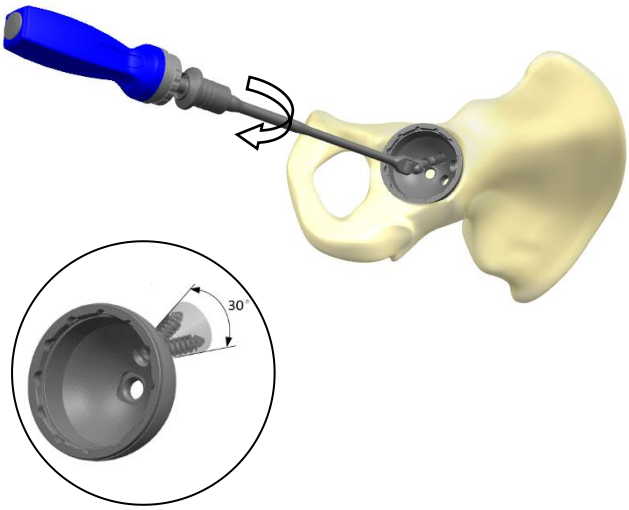
Примірювання та позиціонування ацетабулярного компонента

Нижній край ацетабулярного компонента має бути розташований на рівні дистального краю кульшової западини. Кут встановлення компонента повинен відповідати значенням, визначеним під час передопераційного планування, зазвичай: нахил (абдукція) — 45°, антеверсія — 15–30°.

Для контролю кута встановлення приєднайте стрижень вирівнювання 45° до імпактора ацетабулярного компонента.

	Під час складання імпактора ацетабулярного компонента та стрижня вирівнювання вставте з'єднувальну частину стрижня у відповідне гніздо імпактора, після чого поверніть фіксувальну ручку у напрямку позначок «Lock» і стрілки до повного блокування. Під час розбирання поверніть фіксувальну ручку у напрямку позначок «Unlock» і стрілки, щоб розблокувати з'єднання.
	**Примірювання вкладиша** Після встановлення пробного ацетабулярного компонента в нього слід встановити пробний вкладиш відповідного розміру.Пробні вкладиші відповідають різним діаметрам головки стегнового компонента, а їхнє кольорове маркування допомагає запобігти помилкам. Пробні вкладиші доступні в різних виконаннях — із гвинтами або без них. Пробний вкладиш із гвинтами встановлюють у пробний ацетабулярний компонент, закріплюючи його через верхній отвір за допомогою стандартної викрутки Torx.

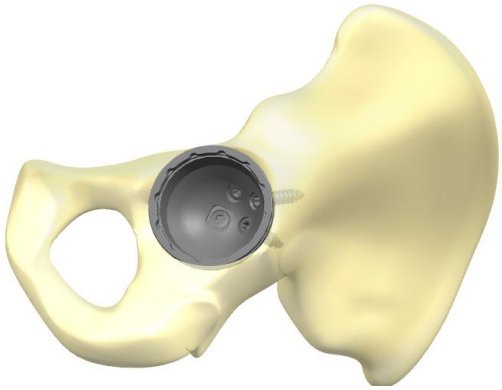
	**Установка ацетабулярної чаші** Ацетабулярний компонент імплантують, використовуючи той самий метод орієнтації, що й під час встановлення пробного ацетабулярного компонента.
	**Фіксація ацетабулярної чаші гвинтами** Для фіксації передбачено три отвори для гвинтів. Свердло використовується разом із напрямною для свердла; доступні свердла двох довжин. Напрямна для свердла має регульований кут нахилу в діапазоні 40°, що дає змогу легко вибрати оптимальний напрямок свердління. Примітка. Для ацетабулярної чашки APEX TT/D отвори для гвинтів попередньо закриті заглушками. Тому перед встановленням гвинтів заглушки необхідно видалити. (Якщо встановлення гвинтів не передбачено, заглушки видаляти не слід.)

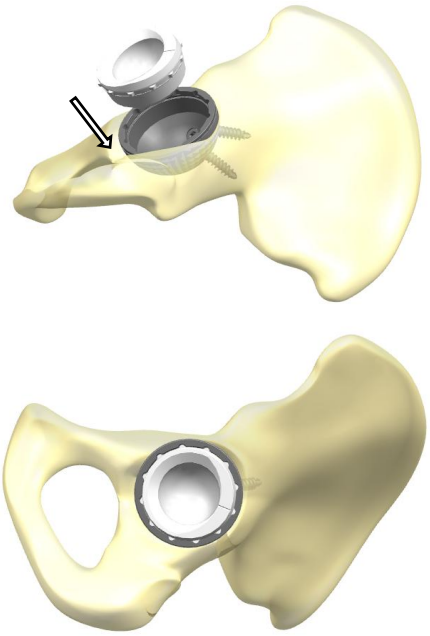
<table>
<tr>
<td>  </td>
<td>Використовуйте глибиномір для вимірювання глибини свердління.</td>
</tr>
<tr>
<td> 
</td>
<td rowspan="2">Використовуйте викрутку VA (зірчасту) для введення ацетабулярного гвинта 6,5 мм.

Гвинт може відхилятися до 30° в отворі для гвинта ацетабулярної чашки.

Після фіксації гвинта інтерфейс ацетабулярної чашки вкручується в заглушку гвинтового отвору ацетабулярної чашки.

Головка викрутки VA (зірчастої) може відхилятися в будь-якому напрямку, а її робоча частина може фіксуватися в будь-якому положенні.

Тріскачковий руків’я забезпечує зручне закручування.</td>
</tr>
<tr>
<td>  </td>
</tr>
</table>

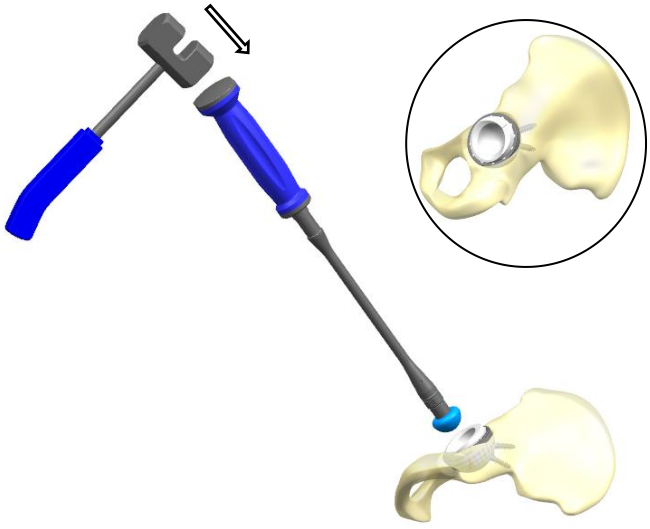


Встановлення вкладиша

Встановіть вкладиш в ацетабулярну чашку.

Перед імпакцією сумістіть анти-ротаційний механізм вкладиша з ацетабулярною чашкою. Переконайтеся, що виїмки (scallops) правильно суміщені з заглибленими ділянками чашки.

Для чашок діаметром 48–62 мм передбачено 12 заглиблених ділянок, а для чашок діаметром 38–46 мм — 8 заглиблених ділянок. Для чашок 38–46 мм вкладиш може обертатися з кроком 45°, а для чашок 48–62 мм — з кроком 30°.



Приєднайте імпактор чашки до з'єднувального елемента імпактора, після чого встановіть з'єднувальний елемент імпактора у гніздо вкладиша та виконайте імпакцію молотком.

Оскільки механізм блокування має конусну прес-фіт конструкцію, необхідне багаторазове постукування до моменту, коли верхня поверхня виїмок (scallops) ацетабулярного вкладиша зрівняється з верхньою поверхнею ацетабулярної чашки.